

Lithiase urinaire

QCM 1

Concernant la lithiase urinaire, indiquez les réponses exactes :

- A. La lithiase urinaire touche préférentiellement les femmes jeunes.
- B. Taux de récurrence est d'environ 50 % à 5 ans.
- C. Les calculs médicamenteux sont radio-opaques et peu visibles au scanner.
- D. Les calculs cystiniques sont généralement résistants à la lithotritie extracorporelle.
- E. Une histoire familiale est retrouvée dans près de 40 % des cas.

QCM 2

Concernant la lithiase urinaire, quels sont les réponses exactes :

- A. Un pH urinaire alcalin favorise la formation des calculs d'acide urique.
- B. Un pH urinaire acide favorise la formation des calculs cystiniques.
- C. Un pH urinaire alcalin favorise la lithiase infectieuse et phosphocalcique.
- D. Le pH urinaire normal est de 5,8.
- E. Les calculs d'infection sont souvent coralliformes.

QCM 3

Le bilan métabolique de première intention pour une lithiase urinaire (quels sont les réponses exactes) :

- A. Comprend systématiquement le dosage de la créatininémie.
- B. Est systématiquement prescrit dès le premier épisode lithiasique.
- C. Comprend le dosage de l'hormone parathyroïdienne (PTH).
- D. Comprend la mesure du pH et de la densité urinaire.
- E. Doit être réalisé à plus de 3 mois d'un épisode aigu.

QCM 4

Concernant les mesures diététiques et le traitement médical de fond de la lithiase urinaire (quels sont les réponses exactes) :

- A. Une diurèse de plus que 2 litres est le premier objectif à atteindre.
- B. Comprend une alcalinisation des urines en cas de calculs d'acide urique.
- C. L'objectif d'un pH urinaire supérieur à 7,5 doit être atteint en cas de calculs cystiniques.
- D. Comprend une alcalinisation des urines en cas de calcul phospho-ammoniac-magnésien.
- E. Un régime hypo-calcique doit être prescrit.

QCM 5

La lithiase urinaire :

- A. Est la 1^{ère} cause d'hospitalisation en urologie
- B. Survient à tout âge
- C. Affiche une légère prédominance féminine
- D. Est le plus souvent primitive
- E. Contient du calcium dans 85% des cas

QCM 6

La crise de colique néphrétique :

- A. Traduit la mise en tension brutale de la voie excrétrice
- B. Est spécifique de l'enclavement d'un calcul au niveau de la voie excrétrice urinaire
- C. À un début et une résolution progressifs
- D. Est caractérisée par une douleur lombaire intense à irradiation postérieure
- E. Est d'évolution paroxystique

QCM 7

Un calcul urinaire :

- A. Peut être invisible à la radiographie de l'AUSP
- B. Peut être invisible au scanner
- C. Se traduit à l'échographie par une formation hyperéchogène avec un renforcement postérieur
- D. Peut se traduire à l'UIV par une image lacunaire
- E. Sa densité scannographique varie en fonction de sa composition cristalline

QCM 8

Les calculs faiblement radio-opaques sont :

- A. D'acide urique
- B. Cystinique
- C. Phospho-amoniaco-magnésien
- D. Oxalocalcique
- E. phosphocalcique

QCM 9

Parmi les éléments suivants quels sont ceux qui orientent vers une lithiase infectieuse ?

- A. Une infection urinaire à Escherichia coli
- B. Un calcul coralliforme
- C. Un pH urinaire alcalin
- D. Une infection urinaire à proteus
- E. Une composition phospho-amoniaco-magnésien à la spectrophotométrie infrarouge

QCM 10

Le bilan étiologique d'une lithiase urinaire :

- A. Est obligatoire dès le 1^{er} épisode lithiasique
- B. Comprend l'analyse spectrophotométrique du calcul
- C. Comporte un bilan biologique sanguin ou urinaire
- D. Doit être réalisé en hospitalisation
- E. Commence dès l'interrogatoire

QCM 11

Le calcul d'acide urique :

- A. Est favorisée par un pH urinaire alcalin
- B. Est invisible à la radiographie de l'AUSP
- C. Est hyperdense au scanner
- D. À souvent un aspect coralliforme
- E. Se traduit par une image lacunaire à l'UIV

QCM 12

Le calcul d'infection :

- A. Se développe à un pH urinaire acide
- B. Est radio transparent
- C. À souvent un aspect coralliforme
- D. Est toujours secondaire à une infection à germes uréasiques
- E. À une composition phospho-amoniaco-magnésienne qui lui est pathognomonique

QCM 13

Les calculs d'acide urique sont :

- A. Toujours bilatéraux
- B. Solubles à un pH acide
- C. Radio-transparents
- D. Habituellement coralliformes
- E. Uniquement vésicaux

QCM 14

Parmi ces éléments, quels sont ceux qui font partie du traitement de la lithiase urique non compliquée avec uricémie à 650 $\mu\text{mol/l}$?

- A. Alcalinisation des urines
- B. Les uricosuriques
- C. Augmentation de la diurèse
- D. Les hypouricémiants
- E. Le kayexalate

QCM 15

Concernant la lithotritie extracorporelle, quelles sont les réponses exactes ?

- A. Correspond à la fragmentation des calculs par des ultrasons
- B. Nécessite un repérage radioscopique ou échographique du calcul
- C. Impose un ECBU négatif
- D. L'obésité est considérée comme un facteur d'échec
- E. Impose la mise en place d'une sonde urétérale pour éviter l'empierrement urétéral

QCM 16

L'urétéroscopie :

- A. Nécessite la stérilité préalable des urines
- B. Est d'autant plus efficace que le calcul est bas situé dans l'uretère
- C. Il est nécessaire d'extraire les calculs après leurs fragmentations
- D. Est plus difficile en cas d'un calcul radio transparent
- E. Le taux d'efficacité atteint les 95 % pour les calculs de l'uretère pelvien

QCM 17

La néphrolithotomie percutanée :

- A. Nécessite la ponction du rein sur un calice inférieur et antérieur
- B. Comporte un risque hémorragique
- C. Peut être proposée pour les calculs radio transparents
- D. Peut nécessiter un complément par lithotritie extracorporelle
- E. Nécessite la stérilité des urines en préopératoire

QCM 18

Les mesures diététiques pour un patient ayant des lithiases urinaires comportent :

- A. Une diurèse d'au moins 2 litres/jour est le premier objectif à atteindre
- B. Une alimentation pauvre en calcium
- C. Éviter les aliments riches en oxalate
- D. Alcalinisation des urines pour les calculs uriques et cystiniques
- E. Suppression des boissons alcalines pour les calculs d'infection

QCM 19

Devant un calcul urétéral radio-opaque de 5mm obstructif, quel traitement proposez-vous de 1^{ère} intention :

- A. Une lithotritie extracorporelle
- B. AINS + hyper diurèse
- C. Une urétéroscopie
- D. Une urétérotomie
- E. Une lithotomie percutanée

QCM 20

Quel(s) traitement(s) proposez-vous pour un calcul pyélique de 3 cm avec 2 prolongements caliciels ?

- A. Une urétéroscopie
- B. Une pyélolithotomie
- C. Une lithotritie extracorporelle
- D. Une néphrolithotomie percutanée +/- urétéroscopie souple
- E. Une alcalinisation des urines

Cas clinique

Un patient de 73 ans, obèse, diabétique, suivi pour goutte, consulte aux urgences pour une CN droite non compliquée.

AUSP : sans anomalies

Échographie rénale : calcul pyélique de 3 cm

Sujet âgé, obèse, diabétique, goutte, calcul radio transparent, 400 UH

Question 1

La prise en charge en urgence comporte

- A. Une hyper diurèse
- B. La prescription d'un AINS
- C. La réalisation d'un bilan étiologique sanguin et urinaire
- D. Le drainage systématique des cavités excrétrices par une sonde urétérale
- E. Une alcalinisation des urines

Cas clinique

Le patient a été exploré à distance par un uroscanner qui a conclu à un calcul pyélique droit de 3 cm obstructif ayant une densité de 400 UH

Question 2

Quelle est la nature présumée de ce calcul

- A. Calcul cystinique
- B. Calcul d'acide urique
- C. Calcul d'infection
- D. Calcul oxalocalcique
- E. Calcul phosphocalcique

Question 3

Quel(s) est (sont) le (les) traitement(s) chirurgical vous pouvez indiquer pour ce calcul

- A. Une néphrolithotomie percutanée
- B. Une lithotritie extracorporelle
- C. Une alcalinisation des urines
- D. Une pyélolithotomie
- E. Une urétéroscopie

Question 4

Quelles mesures diététiques préconisez-vous pour ce patient pour éviter les récives ?

- A. Une alcalinisation des urines
- B. Diurèse de 2 litres / jour
- C. Un régime pauvre en purines
- D. Un régime pauvre en calcium
- E. Limiter la prise de sucres rapides (fructose)

Cas clinique 2

Un patient de 23 ans, aux ATCD familiaux de lithiases urinaires, opéré il y a 03 ans pour un calcul rénal gauche. Ayant des lombalgies gauches évoluant depuis 6 mois, consulte aux urgences pour une CN droite non compliquée qui s'est résolu après un traitement par des AINS.

AUSP : opacités faiblement radio-opaques bilatérales se projetant sur les aires rénales droite et gauche

Échographie rénale : multiples calculs pyéliqués et caliciels du rein droit et gauche de taille variant entre 01 et 03 cm avec un parenchyme rénal qui paraît conservé.

Question 1

Concernant le bilan étiologique chez ce patient :

- A. Il doit être fait le plutôt possible pour commencer le traitement étiologique
- B. Comporte le dosage de la PTH et de la cystinurie libre
- C. Comporte un bilan sanguin et urinaire
- D. Il faut hospitaliser le patient pendant 3 jours pour effectuer le bilan étiologique
- E. La spectrophotométrie infrarouge n'est demandée que si le bilan ne nous oriente vers aucune étiologie

Question 2

Avant de traiter les calculs, quel(s) est (sont) l'examen(s) complémentaire(s) demandez-vous ?

- A. Un uroscanner
- B. Une scintigraphie rénale pour évaluer la fonction de chaque rein
- C. Une urographie intra veineuse
- D. Une urétéro-pyélographie rétrograde au cours de l'acte chirurgical à la recherche d'une anomalie anatomique
- E. Un bilan métabolique étiologique

Cas clinique

Le patient a été exploré par un uroscanner qui a conclu à un calcul pyélique droit de 1,5 cm obstructif et 02 calculs pyélique et caliciel du rein gauche de 03 cm chacun, ayant une densité variant entre 700 et 850 UH

Question 3

Quelle est la nature présumée de ce calcul

- A. Calcul cystinique
- B. Calcul d'acide urique
- C. Calcul d'infection
- D. Calcul oxalocalcique
- E. Calcul phosphocalcique

Question 4

Quel traitement chirurgical vous indiquez en première intention pour le calcul du rein droit sachant que la nature cystinique est confirmée ?

- A. Une néphrolithotomie percutanée
- B. Une lithotritie extracorporelle
- C. Une alcalinisation des urines
- D. Une pyélolithotomie
- E. Une urétérorénoscopie souple

Question 5

Quelles mesures diététiques préconisez-vous pour ce patient ?

- A. Une acidification des urines
- B. Diurèse de plus de 2 litres / jour
- C. Un régime riche en oxalate
- D. Un régime normalisé en calcium
- E. Limiter la prise de sucres rapides (fructose)

Question 6

La surveillance ultérieure pour ce patient comporte :

- A. Surveillance clinique
- B. ECBU
- C. Surveillance de la fonction rénale par une créatininémie
- D. Biopsie rénale chaque 2 ans
- E. Surveillance à vie